内科含诊断 原发性高血压 ★★★（0~3题）

高心病（2019）

高血压病史特别是从未诊治“你不治疗、不听医生的话憋憋出问题”
左室肥厚、A2 亢进、S2 逆 / 反常分裂、S4 奔马律、心尖抬举样搏动、心界多向左下扩大、心尖收缩期杂音

若收缩压和舒张压不在一个等级看较高分级（2023）

	正常血压	正常高值	高血压 1 级	高血压 2 级	高血压 3 级	单纯收缩期高血压	单纯舒张期高血压
收缩压	＜ 120	120~139	140~159	160~179	≥ 180	≥ 140	＜ 140
舒张压	和＜ 80	和 / 或 80~89	和 / 或 90~99	和 / 或 100~109	和 / 或≥ 110	和＜ 90	和≥ 90

危险分层“1234、2234、3444”

	无其他危险因素	1~2 个其他危险因素	≥ 3 个其他危险因素或靶器官损害或 CKD3 期无并发症的糖尿病	临床合并症或 CKD ≥ 4 期有并发症的糖尿病
130~139 和 / 或 85~89		低	中 / 高	高 / 很高
高血压 1 级	低	中	高	很高
高血压 2 级	中	中 / 高	高	很高
高血压 3 级	高	很高	很高	很高

血压突然＞ 180/120（或）→高血压危象（2012、2016、2024、2025）

- 伴靶器官损害→急症 —— 静脉给硝普钠。初期不用呋塞米（除非有心衰）
- 不伴靶器官损害→亚急症 —— 口服快速起效降压药（如 CCB）

治疗（注意禁忌症）（2011、2013、2015、2021）

一般＜ 140/90，合并糖尿病、肾病、心衰、冠心病＜ 130/80（2020）

①伴蛋白尿、糖尿病：ACEI/ARB
②伴痛风：ARB、CCB（心率慢用氨氯地平）
③伴变异型心绞痛、雷诺病、支气管哮喘：CCB
④无合并症的老年（盐敏感）：利尿剂、CCB